



MRI בטן ואגן

שם: ZHERLITSYNA Anastasia **ת.ז.:** ME923960 **תאריך לידה:** 25/04/1976

בדיקה בוצעה ב-24/08/2022 פיענוח מה-31/05/2023

אינדיקציה:

הערכה במסגרת GIST. בשאלה של סרקומה.

תאור הממצאים:

בוצעה השוואה ל-CT קודם מה-23/08/2022

בטן:

הכבד מראה סיגנל תקין. דיסמורפיה עם היפרטרופיה של האונה שמאלית.

מודגמים ממצאים פוקליים בכבד:

- נגע מפורש לסגמנט 5 ו-6 נמדד בכ-16.5*10.8 ס"מ, הגורם ללחץ על מבני שער הכבד
- נגע בקוטר 21*10 מ"מ בסגמנט 8 (קדמי ועליון לעומת נגע הנ"ל)
- נגע בקוטר 82*57 מ"מ בסגמנט 7 ו-8
- נגע בקוטר 12*9 מ"מ בסגמנט 1
- נגע בקוטר 66*45 מ"מ באונה שמאלית, הגורם להרחבה מתונה של דרכי מרה תוך כבדיות מעל

כל הממצאים הנ"ל מראים סיגנל הטרונגי עם מרכיב נקרוטי והמורגי והאדרה הדרגתית. ללא היסטיידיות ב-CT.

לציין נגע ציסטי בקוטר 6 מ"מ מלווה, מאחורי תהליך עיקרי של האונה ימנית, בסגמנט 6 אחורי.

משרעת הכבד נמדדת ב-20.7 ס"מ ב-Midclavicular line.

נוזל בכמות זעירה מסביב לכבד ולטחול.

וריד הפורטלי וורידים הפטיים פתוחים, ללא טרומבוזיס.

תהליך תופס מקום פריאטלי אקסטרינסי ב-Lesser curvature of the stomach, נמדד בכ-55*48 מ"מ, בעל מאפיינים זהים לנגעים בכבד.

כיס מרה נלחץ ונדחה תחתונה ושמאלה, ללא אבן בולטת.

ללא הרחבה פתולוגית של דרכי מרה חוץ כבדיות.

צינור הלב לב ע"ש וירסונג לא מורחב. ללא ממצא בולט בלב לב.

ללא ממצא חריג בטחול או בכליות.

התעבות דיפוזית מתונה של האדרנל שמאל, ללא נודול. אדרנל ימין תקין.



משרעת הטחול נמדדת ב-8.7 ס"מ.

ללא בלוטת לימפה רטרופריטונאלית או מזנטריאלית מוגדלת בשטח הנסרק.

אגו:

הרחם קדמי, ללא סטייה.
מדדים: 79 מ"מ אורך, 50 מ"מ רוחב, 45 מ"מ עובי.
עובי האנדומטריום: 1 מ"מ, בגדר הנורמה.
ללא עיבוי של ה-Junctional Zone, וללא שינוי מיקרוציסטי.
המיומטריום מכיל מיומה עיקרית תוך דפנית ימין (FIGO 5) בקוטר כ-28 מ"מ.
תהליך תופס מקום על גבעול בפונדוס הרחם, נמדד בכ-9*6 ס"מ. הממצא מראה סיגנל T2 מוגבר, עם דיפוזיה גבוהה, ללא רסטריקציה ב-ADC, מתאים ל-Hypercellular leiomyoma על גבעול (FIGO 7). נצפו היסטיידויות בתוכה ב-CT.

תהליך ציסטי בקוטר 65*57 מ"מ בציסטה ימין, עם "Shading", בקשר לאנדומטריומה.
שחלה שמאלית תקינה, ללא ציסטה או אנדומטריומה.

עיבוי רקמתי ב-Torus עם רושם להתדבקות עם הרקטום עליון.
עיבוי רקמתי מתון ב-uterine-sacral ligaments.
התעבות בחלק פרוקסימלי של ה-Round ligaments, יותר בולטת מימין.
ה-Vesico-vaginal and rectovaginal septum נראים תקינים.
ללא הידרוסלפינקס או המטוסלפינקס.
ללא נוזל או ממצא חריג בדוגלס. נוזל פרה-פריטונאלי בכמות זעירה קדימה ושמאלה לשלפוחית.

ללא בלוטת לימפה מוגדלת באגן.
ללא ממצא חריג בשלפוחית השתן (במלאות) או בדופן הבטן.

לסיכום:

1. תמונה מתאימה במקום ראשון ל-GIST בדופן הקיבה עם נגעים משניים בשתי אונות כבד (נגעים נקרוטיים עם שינויים המורגיים ללא היסטיידויות וללא בלוטות לימפה מוגדלת).
2. מיומה על גבעול מתאימה ל-Hypercellular leiomyoma בפונדוס הרחם: בהעדר רסטריקציה ב-ADC, האבחנה של סרקומה הינה בעלת סבירות נמוכה.
3. אנדומטריומה בשחלה ימנית עם נגעי אנדומטריוזיס עמוקה (טורוס וייתכן Round ligaments and USL).
4. נוזל פריטונאלי בכמות זעירה בבטן ובאגן, ללא עדות בולטת לפיזור משני פריטונאלי.

ד"ר זלצר יוהן